

UNIVERSITÉ DE CONSTANTINE

FACULTÉ DE MÉDECINE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025-2026

LES CANCERS PRIMITIFS ET SECONDAIRES DU FOIE

Pr R . BOUZITOUNA

LES CANCERS PRIMITIFS ET SECONDAIRES DU FOIE

Plan :

- I. Introduction :**
- II. Les cancers primitifs :**
 - 1. Carcinome Hépatocellulaire (Hépatocarcinome)**
 - A- Epidémiologie**
 - B- Etiopathogénie**
 - C- Anatomopathologie**
 - D- Diagnostic positif**
 - 1. Clinique**
 - a- Circonstances de découverte**
 - b. Examen clinique**
 - 2. Examens complémentaires**
 - a. Biologie**
 - b. Radiologie**
 - c. Ponction biopsie dirigée sous échographie ou scanner**
 - 3. Bilan d'extension**
 - E- Diagnostic différentiel**
 - F- Traitement**
 - 1. Moyens**
 - a. Traitement curatif**
 - b. Traitement palliatif**
 - 2. Indications**
 - a. CHC sur foie sain**
 - b. CHC sur foie cirrhotique**
 - G- Pronostic**
 - H- Prévention**
 - 2. Cholangiocarcinome**
 - 3. Angiosarcome**
- III. Les cancers secondaires**
- IV. Références bibliographiques**

I. Introduction :

Le foie est composé essentiellement de cellules appelées hépatocytes qui s'organisent en petits groupes, les lobules, autour d'une veine centrale.

- Dans 90 % des cas, le cancer primitif du foie se développe à partir des hépatocytes. On parle de carcinome hépatocellulaire (CHC) ou d'hépatocarcinome.

D'autres formes plus rares de cancers primitifs du foie peuvent se développer à partir des cellules des canaux biliaires (cholangiocarcinome) ou beaucoup plus rarement, des vaisseaux sanguins (hémangio-endothéliome épithélioïde).

- Soit à partir d'un cancer à distance (extra-hépatiques) : Cancers secondaires ou les métastases.

II. Les cancers primitifs :

1. Carcinome Hépatocellulaire (Hépatocarcinome) :

- Prolifération néoplasique d'origine hépatocytaire.
- Il s'agit de loin le cancer primitif du foie le plus fréquent.
- CHC se développe généralement sur **unecirrhose** (75 à 80% des cas), plus rarement sur une **hépatopathie chronique non cirrhotique**, et exceptionnellement sur un **foie sain**.
- Dans les cas de CHC développés sur cirrhose, le pronostic et l'approche thérapeutique sont conditionnés à la fois par le stade du cancer et par la fonction hépatique.
- La détection précoce permet un accès plus fréquent à un traitement à visée curative avec un rapport coût-efficacité très favorable.

A. Epidémiologie :

- **Fréquence** : il représente le 4^e cancer du monde, 3% des cancers en Europe et 10-30% en Afrique et en Asie. En Algérie 3-10%.
- **Age** : l'âge moyen est de 60 ans.
- **Sexe** : prédominance masculine.
- **Le carcinome fibrolamellaire** survient à un âge moins avancé sur un foie sain, et son pronostic est un peu moins sévère.

B. Etiopathogénie

Il convient de distinguer les cancers développés sur foie sain des cancers développés sur foie pathologique.

– Les facteurs favorisants sont :

Cirrhose : il s'agit en général d'un cancer développé sur une cirrhose préexistante, en Europe l'origine de la cirrhose est souvent éthylique dans 90% parfois post hépatitique (Bou C) ou hémochromatique.

En Afrique et en Asie l'origine est souvent une cirrhose post hépatique B.

Les cancers sur cirrhose biliaire ou cirrhose métabolique sont exceptionnels.

Autres facteurs carcinogènes: thorotrast, arsenic, chlorure de vinyl, les androgènes et les œstrogènes.

C. Anatomopathologie :

1. Macroscopie :

Tumeur unique ou multiple, plus ou moins bien limitée, rarement encapsulée, de taille variable: moins de 2 cm « petit CHC » à plusieurs cm.

2. Microscopie:

- Le CHC correspond à une tumeur épithéliale maligne de différenciation hépatocytaire. Il existe plusieurs variantes dont une est à connaître :

* le CHC fibrolamellaire qui est toujours encapsulé, il est d'un meilleur pronostic et survient chez des adultes jeunes ne présentant pas de cirrhose et ayant un taux d'alpha foeto protéine (AFP) normal.

L'extension du CHC se fait principalement par voie vasculaire portale avec développement de nodules filles correspondant à des métastases intrahépatiques de la tumeur ou avec envahissement des troncs veineux (veine porte ++).

Les métastases viscérales peuvent être pulmonaires, surrénaliennes osseuses, ...

D. Diagnostic positif :

1. Clinique

Circonstances de découverte :

- Hépatomégalie.
- Douleurs abdominales de l'hypochondre droit ou de l'épigastre.
- Altération de l'état général : fièvre, asthénie, amaigrissement.
- Ictère cholestatique.
- Décompensation d'une cirrhose connue.
- Une complication : hémopéritoine, une métastase osseuse ou pulmonaire.
- Au cours de la surveillance dans le cadre du dépistage chez un sujet porteur d'une cirrhose.

Examen clinique :

- L'hépatomégalie : parfois visible à l'inspection, à la palpation elle est dure ; à bord inférieur tranchant sensible de surface irrégulière déformée par des nodules. On mesure la flèche hépatique sur la ligne medio-claviculaire droite.
- L'ictère : cutanéomuqueux cholestatique (urines foncées, selles décolorées)
- On peut rechercher une ascite d'abondance variable.
- L'auscultation peut percevoir un frottement et si la tumeur est hypervascularisée, un souffle.

2. Examens complémentaires

a. Biologie

- Un syndrome de cholestase :
 - Un syndrome paranéoplasique : hypoglycémie, hypercalcémie, polyglobulie
 - Une insuffisance hépatique : TP bas, hypoprotidémie.
 - Marqueurs tumoraux : la recherche de l'alphafoetoprotéine dans le sang est fondamentale : un taux > 500 ng / ml spécifique du CHC.
- Le dosage d'autres marqueurs n'est pas utilisé en routine: la décarboxy prothrombine (DCP), les anticorps monoclonaux.

b. Radiologie

L'échographie hépatique :

Découvrir un ou plusieurs nodules hypo-échogènes, dont elle précise la taille, le nombre, le siège et leur retentissement (effet de masse). Elle permet de faire une ponction échoguidée ainsi que la recherche d'anomalie associée (ascite, thrombose porte). L'échographie couplée au doppler peut détecter les tumeurs hypervascularisées.

– **La tomodensitométrie hépatique:**

Permet de visualiser une ou plusieurs masses hypodenses prenant le contraste de façon hétérogène et précise également le siège, le nombre et la taille.

(Lésion **HYPERVASCULAIRE** au temps artériel(wash-in) ET présentant un **LAVAGE(wash-out)** au temps portal ou au temps tardif sur un scanner ou une IRM).

- **L'angiographie lipiodolée** : examen fiable pour la détection de lésions de très petite taille.
- **L'imagerie par résonance magnétique(IRM)**:intérêt dans la détection de tumeur de petite taille et dans certains diagnostics différentiels (stéatose focalisée, angiome).
- **La scintigraphie** n'est plus guère utilisée.
- **Le TEP-scan** au 18F-FDG et/ou à la choline n'ont pas leur place dans le diagnostic du CHC.

c. Ponction biopsie dirigée sous échographie ou scanner

La ponction biopsie du foie tumoral et non tumoral est recommandée. Elle doit être faite au travers d'une épaisseur notable de parenchyme non tumoral et avec une protection du trajet pariétal pour limiter le risque d'essaimage sur le trajet de ponction.

3. Bilan d'extension

- Clinique : à la recherche d'une ascite, d'adénopathies.
- l'AFP (intérêt dans le pronostic et le suivi).
- Radiologique : IRM abdominale + scanner thoracique ou scanner thoracoabdominal (avec injection de produit de contraste).
- Bilan du terrain :

Un bilan du terrain préopératoire est systématique, il comprend un bilan d'opérabilité (Groupage, FNS, bilan rénal, cardiovasculaire...) et un bilan du degré d'insuffisance hépatocellulaire selon la classification de CHILD PUGH.

E. Diagnostic différentiel

Différents diagnostics sont à discuter

- un abcès du foie à pyogènes.
- un kyste hydatique notamment pseudo tumoral stade IV.
- une hyperplasie nodulaire focale.
- une stéatose localisée.
- une échinococcose alvéolaire hépatique.

F. Traitement

1. Moyens

a. Traitement curatif:

Traitement chirurgical :

Seul traitement susceptible d'amener la guérison

- Tumorectomie, segmentectomie.
- hépatectomie réglée droite ou gauche
- hépatectomie totale avec transplantation hépatique

Destruction per-cutanée :

Cette méthode simple et habituellement bien tolérée, qui a l'avantage de préserver le parenchyme non tumoral, est une alternative à la chirurgie.

Un traitement par **radiofréquence** est envisageable :

- Si la tumeur mesure moins de 3 cm, est accessible à la ponction sous échographie ou scanner, et se situe à distance du hile et des grosses voies biliaires.
- La destruction per-cutanée doit être proposée aux malades ne relevant pas d'une résection avec un risque de récurrence locale important.
- Une anastomose bilio-digestive ou une ascite importante sont des **contre-indications**.

b. Traitement palliatif :

- Traitement médical symptomatique, améliore le confort du malade : antalgique, corticoïde et un traitement hormonal (tamoxifène).
- Chimiothérapie par voie artérielle intra hépatique.
- Chimio-embolisation.
- Destruction per-cutanée
- Alcoolisation par injection per cutanée échoguidée d'alcool absolu.

2. Indications

a. CHC sur foie sain

- Le CHC sur foie sain est plus souvent volumineux au moment du diagnostic, il est une indication de résection, en l'absence de diffusion bi-lobaire ou de métastase.
- Quelle que soit la taille de la tumeur, la présence d'un parenchyme normal permet une hépatectomie extensive qui est bien tolérée, car ces malades sont habituellement en bon état général.

b. CHC sur foie cirrhotique

En fonction de la taille, de l'extension de la tumeur et du degré d'insuffisance hépatique

- Tumeur unique < 5 cm
 - Sujet CHILD PUGH A : une hépatectomie réglée est justifiée
 - Sujet CHILD PUGH B ou C : une transplantation est indiquée
- Tumeur multiple avec extension métastatique : Traitement symptomatique, chimio-embolisation ou alcoolisation sont indiqués.

G. Pronostic

- Le pronostic dépend de la taille de la tumeur et de l'extension tumorale extra hépatique.
- Le pronostic des carcinomes hépatocellulaires reste très défavorable avec une survie globale inférieure à 20 % à une année.
- L'amélioration du pronostic passe par la prévention.

H. Prévention

La prévention intervient sur les facteurs favorisants:

- Lutte contre l'alcoolisme.
- Vaccination contre l'hépatite B.
- Dépistage à un stade précoce du cancer chez les sujets à risque cirrhotiques.

4. Cholangiocarcinome :

- **Tissus d'origine:** Revêtement des canaux biliaires intra-hépatiques → Cholangiocytes
- **Fréquence:** la deuxième cause des tumeurs malignes primitives du foie (10%).

- **Les facteurs favorisant le développement du cholangiocarcinome** sont la stase biliaire, l'inflammation chronique des voies biliaires et l'infection.
- **Les facteurs de risque** sont les kystes du cholédoque, la cholangite sclérosante primitive, la lithiase biliaire, la maladie de Caroli, l'adénome des voies biliaires, la papillomatose biliaire.
- **α FP: normale**
- **Traitement curatif:** Chirurgie seule (stade précoce).
- **Pronostic:** Mauvais.

5. Angiosarcome : (hémangiosarcome ou hémangioendothéliome malin)

C'est la plus fréquente des tumeurs mésoenchymateuses malignes du foie. Développé à partir des cellules endothéliales bordant les sinusoides, il affecte plus souvent les hommes dans la cinquième ou sixième décennie exposés à certains carcinogènes (thorotrast, chlorure de vinyle, arsenic) ou à la prise de stéroïdes anabolisants. Le temps de latence entre l'exposition et l'apparition de l'angiosarcome est d'environ 20 à 35 ans. Le pronostic est sombre puisque la survie moyenne est de 6 mois. Les patients meurent d'insuffisance hépatocellulaire ou d'hémorragie intra-abdominale par rupture de la tumeur. La chirurgie est rarement possible en raison de l'extension locale et des fréquentes métastases. La chimiothérapie semble inefficace dans ce type de tumeur.

III. Les cancers secondaires :

- Les métastases hépatiques sont les plus fréquentes des tumeurs du foie.
- Elles compliquent surtout les cancers drainés par la circulation splanchnique (côlon, pancréas, estomac), mais peuvent se voir dans la quasi-totalité des cancers généralisés (poumon, ovaires, sein, œsophage, rein, tumeurs neuro-endocrines etc...).
- Le problème essentiel est en fait de différencier cancer primitif et cancer secondaire du foie.
- Le tableau clinique et les données biologiques ne permettent pas de trancher.
- Un taux élevé d'alpha foetoprotéine peut révéler un cancer primitif ou une métastase hépatique d'un cancer digestif. Donc Le dosage d'alpha foetoprotéine n'est pas spécifique.
- Le diagnostic sera établi grâce à :
 - L'analyse histologique ou cytologique des lésions ponctionnées échoguidées
 - La mise en évidence d'un cancer primitif qui permet alors d'affirmer la nature secondaire du cancer du foie.
- Les améliorations des techniques chirurgicales et des traitements périopératoires ont permis des résections hépatiques plus sûres.
- La résection chirurgicale, lorsqu'elle est réalisable, est le traitement de première intention des métastases hépatiques.
- Les métastases hépatiques non résécables peuvent bénéficier de traitements systémiques et de nombreux traitements locaux comme l'ablation par radiofréquence, par micro-ondes, la cryothérapie, la chimiothérapie intra-artérielle hépatique, ou la radio-embolisation.
- D'immenses progrès ont été faits ces dernières années dans la prise en charge des métastases hépatiques, permettant à des situations considérées il y a peu comme « palliatives » de bénéficier d'un contrôle tumoral chronique, voire être « guéries » avec une éradication complète de la maladie métastatique.

IV. Références bibliographiques :

- Blanc JF, et al. Thésaurus National de Cancérologie Digestive (TNCD). Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2021 Mar; 45(2):101590. DOI: 10.1016/j.clinre.2020.101590. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33780876. **Et mise à jour 2023 :** JF Blanc et al. Carcinome hépatocellulaire. Thésaurus National de Cancérologie Digestive, septembre 2023, en ligne [<http://www.tncd.org>].

- C. Fenioux, C. Tournigand, A. Luciani, A. Laurent, E. Kempf. Métastases hépatiques. Volume 14 ; n°3. EMC Traité de Médecine Akos 1. décembre 30, 2020.
- M-P. Vullierme et al. What is new in the management of hepatocellular carcinoma complicating cirrhosis? Journal of VisceralSurgery, DOI: 10.1016/j.visc surg. 2010.02.003.
- L. Fartoux, C. Desbois-Mouthon, O. Rosmorduc. Carcinome hépatocellulaire : épidémiologie, physiopathologie et diagnostic.7-038-A-18. EMC Hépatologie. 2009 Elsevier Masson SAS.
- F. Cholet, J.-B. Noursbaum, N. Lagarde, B. Turlin. Tumeurs hépatiques malignes primitives en dehors du carcinome hépatocellulaire. 7-038-A-25. EMC Hépatologie. 2005 Elsevier SAS.